

GUIDE PRATIQUE DÉTAILLÉ

Prise en charge clinique des survivantes de viol et de violence conjugale

WHO, UNFPA and UNHCR · English · 2020

Important: Il s'agit d'un guide de lecture non officiel détaillé et non d'une traduction officielle. Consultez la publication originale pour connaître les exigences complètes et le contexte.

Basé sur la publication originale

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf>

Contenu

1. Objectif et portée
2. Conseils clés
3. Comment utiliser ce guide
4. Principes centrés sur le survivant
5. Séquence de réponse pratique
6. Contrôles de sécurité et de qualité
7. Liste de contrôle des actions

01 Objectif et portée

- Conseils cliniques pour des soins compatissants et fondés sur des données probantes après un viol et une violence conjugale, y compris un traitement urgent, une documentation et un suivi.
-

02 Conseils clés

- Traitez d'abord les conditions potentiellement mortelles tout en préservant la dignité, la vie privée et le contrôle du survivant sur chaque étape de l'examen.
- Obtenir le consentement éclairé séparément pour l'examen, la collecte de preuves, le traitement, les photographies et le partage d'informations ; le consentement peut être retiré.
- Proposer une prévention des grossesses en temps opportun, une prophylaxie post-exposition au VIH et des soins contre les infections sexuellement transmissibles conformément aux protocoles nationaux en vigueur.
- N'effectuez pas de tests de virginité ; cela n'a aucune validité scientifique et peut causer des dommages physiques et psychologiques.
- Utilisez un examen tenant compte des traumatismes : expliquez chaque étape, minimisez les répétitions, autorisez une personne de soutien si vous le souhaitez et arrêtez-vous lorsqu'on vous le demande.
- La collecte de preuves médico-légales doit respecter la législation locale, les règles de chaîne de traçabilité et les capacités de laboratoire disponibles ; les soins médicaux ne doivent jamais dépendre de la collecte de preuves.
- Évaluez la santé mentale, le stress aigu, le risque d'automutilation et les besoins sociaux sans pathologiser les réponses traumatiques attendues.
- Planifiez le suivi des résultats des tests, des vaccinations, de l'observance des médicaments, de la grossesse, de la guérison, de la santé mentale et de l'orientation sécuritaire.

Comment utiliser ce guide

- Ce guide transforme la publication source en une aide à la lecture pratique. Il est conçu pour les survivants, les sympathisants de confiance, le personnel de santé et des services sociaux et les responsables de programmes. Il ne remplace pas les services d'urgence, les soins médicaux, les conseils juridiques ou la publication source complète.
 - Utilisez uniquement les pièces adaptées à la situation de la personne. Préservez son choix, son intimité et son rythme. Si une action suggérée pourrait exposer la navigation, les appels, les documents ou la localisation à une personne abusive, choisissez d'abord un appareil, un lieu ou une heure plus sûrs.
-

Principes centrés sur le survivant

- La sécurité passe avant tout. Demandez ce qui rendrait les heures ou les prochains jours plus sûrs et évitez les mesures susceptibles de provoquer des représailles. N'exigez jamais de divulgation afin d'offrir une aide de base.
- Respecter l'autonomie et le consentement éclairé. Expliquer les options réalistes, les avantages, les limites et les risques possibles ; c'est le survivant qui décide de la suite des événements, à moins qu'une obligation de sauvegarde légale immédiate ne s'applique.
- Protégez la confidentialité. Collectez le minimum d'informations, restreignez l'accès, convenez de méthodes de contact sûres et expliquez les limites avant que les informations ne soient partagées.
- Assurer un accès équitable. Tenez compte du handicap, de la langue, de l'âge, du statut migratoire, de la pauvreté, de l'isolement rural, de l'orientation sexuelle et d'autres obstacles sans stéréotypes.

05 Séquence de réponse pratique

- Commencez par la sécurité immédiate et les besoins de santé urgents. Demandez en privé, sans la présence de l'agresseur présumé, s'il est possible de parler en toute sécurité et si la personne a besoin de soins d'urgence.
- Écoutez sans interrogation. Validez ce qui s'est passé, évitez les reproches et n'exigez pas de récit chronologique ou de preuve. Enregistrez uniquement ce qui est nécessaire et utilisez les propres mots de la survivante.
- Proposer un petit nombre d'options vérifiées : soins médicaux, hébergement sûr, soutien psychosocial, informations juridiques, services de police ou de protection le cas échéant. Expliquez qu'accepter un service ne nécessite pas d'accepter tous les autres.
- Faites une référence chaleureuse lorsque le consentement est donné : confirmez que le service est ouvert, accessible et sûr ; expliquer à quoi s'attendre ; et évitez d'envoyer le survivant à plusieurs reprises entre les agences.
- Convenez d'un suivi et d'un moyen sûr de communiquer. Ne laissez pas de messages d'identification, n'envoyez pas de notifications révélatrices et ne stockez pas de fichiers sous des noms évidents si les appareils peuvent être surveillés.

06 Contrôles de sécurité et de qualité

- Ne confrontez pas l'agresseur présumé, n'intervenez pas dans une relation violente, ne promettez pas un résultat que vous ne pouvez pas contrôler ou ne faites pas pression sur un survivant pour qu'il parte immédiatement.
- N'utilisez pas de numéros de téléphone ou de références non vérifiés. Les services peuvent fermer, modifier les règles d'éligibilité ou partager des informations de manière dangereuse ; confirmer les détails avant la publication ou le renvoi.
- Les organisations doivent former le personnel, superviser les cas difficiles, créer des règles de documentation confidentielles, maintenir des cartes de référence à jour et offrir un soutien au personnel pour réduire l'épuisement professionnel et les pratiques néfastes.

Liste de contrôle des actions

- Est-il sécuritaire de parler, de lire ou de conserver ce document en ce moment ?
- Les blessures urgentes, les problèmes de grossesse, les soins en cas de violence sexuelle et le risque de suicide ont-ils été pris en compte ?
- La survivante a-t-elle choisi quelles informations peuvent être enregistrées ou partagées ?
- Les obstacles à l'interprétation, à l'accès des personnes handicapées, à la garde d'enfants, au transport et aux coûts sont-ils résolus ?
- Les références sont-elles vérifiées et existe-t-il un plan de suivi sécurisé ?
- A-t-on dit à la personne que la violence n'est pas de sa faute et qu'elle peut refuser n'importe quelle option ?